3.2.8.1. 노인환자 진료

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	노년내과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 6.2 취약환자 권리보호 JCI Standard 7th Edition: PCC.1.5, AOP.1.6, COP.3

제1조 (목적)

1. 정신적, 육체적으로 취약하고 의존적인 노인에 대한 적절한 진료지침 및 절차를 마련하여, 이들의 의학적 필요를 파악하고 이를 해결하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 노인환자: 65세 이상의 환자
2. ADL: Activities of Daily Living
3. CGA: Comprehensive Geriatric Assessment

제3조 (절차)

1. 노인환자의 치료계획
   1) 담당 의료진은 노인환자의 영양상태, 운동능력, 인지기능 등을 평가하고, 초기평가 결과에 따라 심층평가가 필요한 경우 노년내과 의료진 등 전문가에게 진료를 의뢰한다. 단, 노년내과 환자의 경우 CGA와 같은 노인포괄기능평가를 통해 초기평가가 시행된다.
   2) 환자의 근력약화를 방지하기 위해 최대한 보행을 독려하고 필요 시 적절한 운동치료를 받을 수 있도록 한다.
   3) 노인환자의 경우 다약제 사용으로 인한 문제 발생의 가능성이 높아(Polypharmacy) 가능한 약물의 치료요법(Regimen)을 간단하게 하고, 자주 검토한다.
   4) 감염예방을 위해 가능한 빨리 정맥주사(IV Line)와 삽입관(Catheter)을 제거한다.
   5) 가능한 신체보호대 사용을 피한다.
   6) 적응증이 되는 상태일 때만 섬망 약물요법(Delirium Medication)을 사용하며 정신건강의학과와 협의하여 적절한 약물/인지행동치료를 시행한다.
   7) 과도 진정(Over-Sedate)은 금지한다.
   8) 의사결정에 환자 및 가족 구성원을 참여시킨다.
   9) 신체적으로 제한이 있는 경우 적절한 보조기구를 제공한다.
   10) 학대와 방임(의심) 노인환자의 경우 세브란스병원 내규 [6.2.1. 취약환자 서비스]에 따라 관리한다.

2. 입원 시 보호자 교육
   1) ADL 감소가 있는 노인환자는 낙상, 골절, 섬망, 감염, 욕창, 요실금 및 이외의 합병증이

생길 수 있으므로 이에 대하여 담당 의료진은 대리인에게 설명한다.

2) 환자의 간병을 수행할 수 있도록 지속적으로 교육 관리한다.

3. 동의서 작성이 필요한 경우

1) 이해하기 쉬운 용어로 천천히 설명하고 의사소통한다.

2) 인지능력에 따라 대리인을 의사결정에 참여시킨다.

4. 모니터링

1) 담당 의료진은 주기적으로 노인환자의 영양상태, 운동능력, 인지기능 등을 평가하고 변화가 있을 경우에는 필요 시 해당 진료과에 협의진료를 의뢰한다. 단, 노년내과 환자의 경우 CGA와 같은 노인포괄기능평가를 통해 평가가 시행된다.

2) 협의진료를 통해 환자의 포괄적 관리가 적절하게 이루어지는지에 대해 주기적으로 평가한다.

3) 취약한 노인환자를 고려한 환자의 권리 보호와 안전을 지속적으로 확인한다.

5. 담당 의료진은 진료 및 교육 등 일체의 내용을 기록하고 공유한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)